Клинические рекомендации

Сифилис

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A50** — Врожденный сифилис **A51** — Ранний сифилис **A52** — Поздний сифилис **A53** — Другие и неуточненные формы сифилиса
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 09.07.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/197_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Классификация 3

2.3 Клиническая картина 3

3. Диагностика 4

3.1 Прямые методы 4

3.2 Серологическая диагностика 4

3.3 Спинномозговая пункция 4

3.4 Другие исследования 5

4. Лечение 5

4.1 Препараты 5

4.2 Лечение взрослых по формам 5

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 6

5.1 Профилактика 6

5.2 Показания к госпитализации 6

6. Источник и актуальность 6

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 6

1. Основные положения

- Сифилис — инфекция, вызываемая бледной трепонемой и передающаяся преимущественно половым путём; течение стадийное, рецидивирующее, прогрессирующее.
- **Поражения ЛОР-органов и полости рта**
  1. атипичный первичный аффект — шанкр-амигдалит: одностороннее увеличение и уплотнение нёбной миндалины;
  2. вторичный период — розеолёзные и папулёзные сифилиды слизистых оболочек, боль в горле;
  3. третичный период — бугорковые и гуммозные сифилиды с дефектами тканей;
  4. врождённый сифилис — специфический ринит у грудных детей; лабиринтная глухота в триаде Гетчинсона, деформации носа.
- Абсолютное доказательство — бледная трепонема или её ДНК/РНК в отделяемом очагов. Основа диагностики — сочетание нетрепонемного (РМП/RPR) и трепонемного тестов; при отологической симптоматике показана спинномозговая пункция для исключения нейросифилиса.
- Препарат первого выбора — бензилпенициллин. Превентивное лечение контактных с ранним сифилисом — **не позднее 2 месяцев** после контакта: бензатина бензилпенициллин 2,4 млн ЕД в/м однократно.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Сифилис — инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой (Treponema pallidum), передающееся преимущественно половым путём, со стадийным, рецидивирующим, прогрессирующим течением.

Поражаются

1. кожа и слизистые оболочки;
2. нервная система;
3. внутренние органы;
4. опорно-двигательный аппарат.

Treponema pallidum — спиралевидный микроорганизм, не культивируется на искусственных средах; вне организма неустойчива, гибнет при нагревании, высушивании, под действием антисептиков; устойчива при низких температурах и во влажной среде.

2.2 Классификация

Приобретённый сифилис

1. **первичный** — серонегативный и серопозитивный; при внеполовой локализации шанкра — «экстрагенитальный»
2. **вторичный** — свежий (обильные мелкие симметричные сифилиды и остатки первичного аффекта) и рецидивный (немногочисленные крупные сгруппированные сифилиды)
3. **третичный** — активный (бугорковые и гуммозные сифилиды) и скрытый
4. **скрытый** — ранний (давность **до 2 лет**), поздний (**более 2 лет**), неуточнённый
5. **нейросифилис** — ранний (**до 5 лет**) и поздний (**более 5 лет**), асимптомный и манифестный
6. **сифилис внутренних органов и опорно-двигательного аппарата** — ранний и поздний

1. **ранний врождённый** — у детей **до 2 лет**: активный или скрытый
2. **поздний врождённый** — у детей **старше 2 лет**: активный или скрытый

Граница между ранними и поздними формами — **2 года** с момента заражения: до этого срока пациент эпидемиологически опасен, а бугорки и гуммы, как правило, не появляются.

2.3 Клиническая картина

Инкубационный период в среднем **от 2 недель до 2 месяцев**, крайние значения — 8 и 190 дней.

Первичный аффект (твёрдый шанкр)

1. эрозия или язва от 2–3 мм до 1,5–2 см и более, круглая, с ровными краями;
2. дно гладкое, блестящее, отделяемое скудное серозное;
3. безболезненная, с плотноэластическим инфильтратом в основании;
4. безболезненный регионарный лимфаденит.

Первичный период длится в среднем **6–7 недель**.

1. **шанкр-амигдалит** — одностороннее увеличение и уплотнение нёбной миндалины
2. **шанкр-панариций** — болезненная язва на отёчной концевой фаланге пальца
3. **индуративный отёк** — одностороннее увеличение половой губы или отёчность крайней плоти

Вторичный период наступает **через 2–3 месяца** после инфицирования; пациенты могут жаловаться на повышение температуры, головную боль, утомляемость, боль в горле.

Проявления

1. розеолёзные и папулёзные, реже папуло-пустулёзные высыпания на коже;
2. на слизистых оболочках — сифилиды от опаловых папул до эрозивных, вегетирующих, рагадиформных, редко язвенных;
3. сифилитическая лейкодерма и алопеция.

Третичный сифилис развивается, как правило, после скрытого периода, спустя многие годы после заражения.

1. бугорковые и гуммозные сифилиды, третичная розеола Фурнье на коже и видимых слизистых оболочках, часто с дефектами тканей;
2. поражения внутренних органов, костей и суставов;
3. поражение нервной системы.

1. **ранний врождённый** — патогномоничны сифилитический пемфигоид, диффузная инфильтрация кожи Гохзингера, специфический ринит (сухая, катаральная и язвенная стадии), остеохондрит Вегнера
2. **поздний врождённый** — достоверные признаки — триада Гетчинсона: паренхиматозный кератит, лабиринтная глухота, зубы Гетчинсона; вероятные — саблевидные голени, деформации носа, лучистые рубцы вокруг рта, «готическое» нёбо

Кроме того, при позднем врождённом сифилисе характерны бугорковые и гуммозные сифилиды кожи и слизистых оболочек.

Нейросифилис может проявляться головной болью, головокружением, тошнотой, нарушением зрения, слуха, речи, судорогами, нарушением координации. Ранние формы — менинговаскулярный сифилис, сифилитический увеит; поздние — прогрессирующий паралич, спинная сухотка, атрофия зрительных нервов, гуммозный нейросифилис.

---

3. Диагностика

3.1 Прямые методы

Абсолютным доказательством является обнаружение бледной трепонемы в образцах из очагов поражения или её ДНК/РНК методом ПЦР.

Методы

1. микроскопия в тёмном поле;
2. прямая иммунофлюоресценция;
3. ПЦР.

Прямые методы применяют при ранних формах с эрозивно-язвенными элементами и для подтверждения врождённого сифилиса, в том числе в отделяемом слизистой оболочки носа.

3.2 Серологическая диагностика

1. **массовый скрининг** — нетрепонемные тесты (РМП, RPR, VDRL)
2. **особые группы (беременные, доноры и др.)** — комбинация нетрепонемного и трепонемного тестов
3. **контактные при давности контакта** не более 2 месяцев — один из трепонемных тестов

1. **ранние манифестные формы** — нетрепонемный тест количественно + трепонемный (РПГА, ИФА, иммуноблоттинг)
2. **скрытые и поздние формы, ложноположительные результаты** — нетрепонемный тест количественно + трепонемные

У ВИЧ-инфицированных результаты интерпретируют по тем же алгоритмам.

3.3 Спинномозговая пункция

Показания к исследованию цереброспинальной жидкости (ВИЧ-отрицательные пациенты)

1. неврологическая, офтальмологическая, отологическая симптоматика или психические расстройства — независимо от стадии;
2. скрытые и поздние формы;
3. злокачественное течение раннего сифилиса; вторичный сифилис с лейкодермой и алопецией;
4. специфические поражения внутренних органов; подозрение на врождённый сифилис;
5. отсутствие негативации нетрепонемных тестов после лечения ранних форм; нарастание титра при контроле после лечения поздних форм.

ВИЧ-инфицированным пункция показана также при титре РМП/RPR **≥ 1:32** и CD4+ **≤ 350 клеток/мкл**.

3.4 Другие исследования

1. **всем, кроме первичного сифилиса** — биохимический анализ крови с печёночными показателями
2. **всем** — антитела к ВИЧ-1/2, HBsAg, антитела к вирусу гепатита С
3. **нейросифилис** — МРТ и КТ головного мозга, ЭЭГ
4. **висцеральный сифилис** — эхокардиография, КТ и МРТ внутренних органов, ЭКГ и др.

---

4. Лечение

4.1 Препараты

Препаратом первого выбора является бензилпенициллин. Применяют также бензатина бензилпенициллин (дюрантный), его комбинацию с бензилпенициллином прокаина, доксициклин, эритромицин, цефтриаксон.

Превентивное лечение проводят лицам после полового или тесного бытового контакта с больным ранним сифилисом, если с момента контакта прошло **не более 2 месяцев**. Препарат выбора — бензатина бензилпенициллин 2,4 млн ЕД в/м однократно (по 1,2 млн ЕД в каждую ягодичную мышцу).

4.2 Лечение взрослых по формам

Схемы лечения взрослых

Форма	Схемы
Первичный	бензатина бензилпенициллин 2,4 млн ЕД в/м 1 раз в 5 дней, 3 инъекции; или бензилпенициллина новокаиновая соль 600 тыс. ЕД 2 раза в сутки 14 дней; или натриевая соль 1 млн ЕД каждые 4 часа 14 дней
Вторичный	бензилпенициллина натриевая соль 1 млн ЕД каждые 4 часа 28 дней; или новокаиновая соль 600 тыс. ЕД 2 раза в сутки; или бензатина бензилпенициллин 2,4 млн ЕД 1 раз в 5 дней, 6 инъекций
Ранний скрытый	бензилпенициллина натриевая соль 1 млн ЕД в/м 28 дней; или новокаиновая соль 600 тыс. ЕД 2 раза в сутки 28 дней
Третичный, поздний и неуточнённый скрытый	бензилпенициллин 28 дней, через 2 недели — второй курс 14 дней
Ранний нейросифилис	бензилпенициллина натриевая соль 12 млн ЕД 2 раза в сутки в/в капельно 20 дней или 4 млн ЕД 6 раз в сутки в/в струйно 20 дней
Поздний нейросифилис	те же схемы в/в, через 2 недели — второй курс

Пероральные препараты при поздних формах менее эффективны и часто ведут к серологической резистентности; их допускают лишь при непереносимости всех парентеральных препаратов.

Манифестный нейросифилис лечат в неврологическом или психиатрическом стационаре.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Ведение контактных

1. **контакт** **не более 2 месяцев** **назад** — превентивное лечение
2. **2–4 месяца** — двукратное клинико-серологическое обследование с интервалом 2 месяца
3. **более 4 месяцев** — однократное обследование
4. **переливание крови больного** — **не более 3 месяцев** — лечение по схеме первичного сифилиса; **3–6 месяцев** — двукратный контроль; **более 6 месяцев** — однократное обследование

Антенатальная профилактика врождённого сифилиса включает трёхкратное серологическое обследование беременных: при обращении в женскую консультацию, **на сроке 28–30 недель** и **за 2–3 недели до родов**.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. беременные, нуждающиеся в специфическом и профилактическом лечении;
2. дети с врождённым сифилисом;
3. дети с приобретённым сифилисом **до 10 лет** и (или) при соматической патологии;
4. пациенты, которым требуется регулярное проведение лечебных процедур.

Критерии выписки

1. полный курс специфической терапии по стадии и форме сифилиса;
2. разрешение заразных проявлений.

При выявлении антител к ВИЧ пациента направляют в региональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом; сифилис у ВИЧ-инфицированных лечат по тем же схемам. Нетрепонемные тесты у них часто остаются положительными после лечения.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Сифилис»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 09.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	197_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество дерматовенерологов и косметологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Вторичный сифилис: в рекомендации бензилпенициллина новокаиновая соль 600 тыс. ЕД 2 раза в сутки назначается на 20 дней, в комментарии к ней — на 28 дней.
- Ранний скрытый сифилис: в рекомендации бензилпенициллина натриевая соль 1 млн ЕД вводится каждые 6 часов, в комментарии — каждые 4 часа.